

**Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии
аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон**

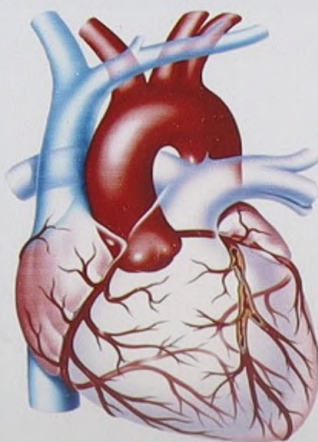
**МДТ «Донишкадаи таҳсилоти
баъдидипломи кормандони соҳаи
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон»**

**Кафедраи кардиология бо курси
фармакологияи клиникӣ**

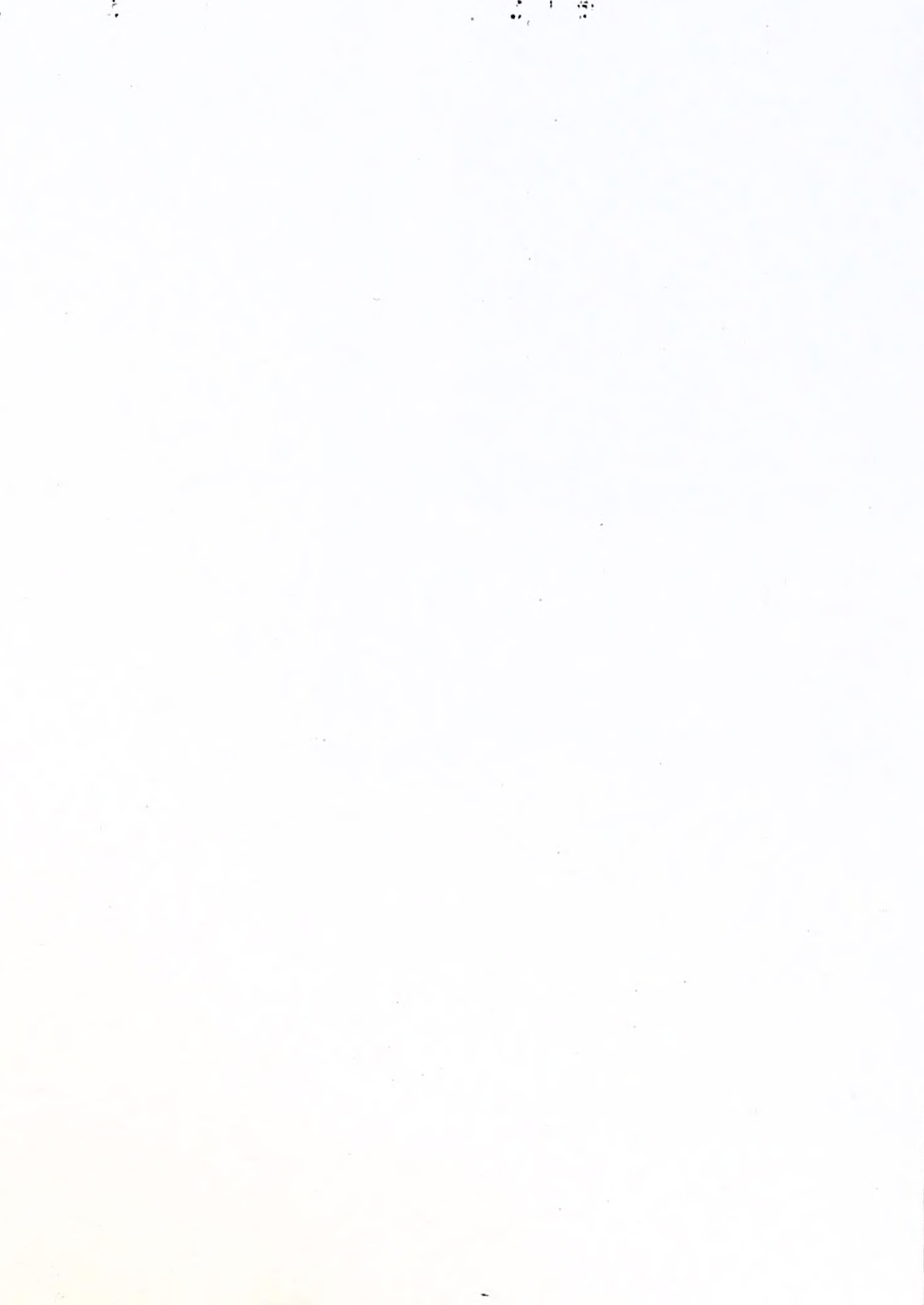
Ҷ.Ҳ. НОЗИРЗОДА, А.Р. НАРЗУЛЛАЕВА

БЕМОРИИ ИШЕМИЯВИИ ДИЛ

Дастури талимӣ-услубӣ



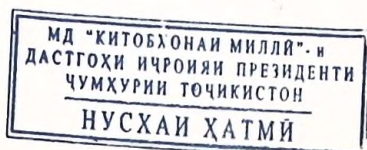
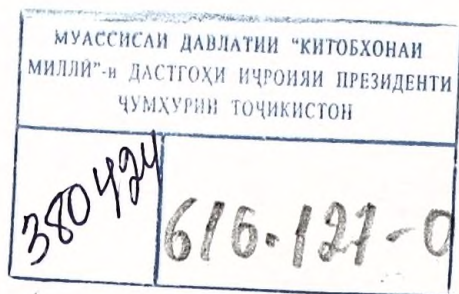
Душанбе-2025



Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
МДТ «Донишкадан таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи
тандурустии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Кафедраи кардиология бо курси фармакологияи клиникӣ

Ҷ.Ҳ. НОЗИРЗОДА, А.Р. НАРЗУЛЛАЕВА

БЕМОРИИ ИШЕМИЯВИИ ДИЛ
Дастури талимӣ-услубӣ



Душанбе 2025



Бемории ишемиявии дил. Нозирзода Қ.Х., Нарзуллаева А.Р.
Дастури таълимӣ-услубӣ. Душанбе, 2025. 32 саҳ.

Бо қарори Шӯрои Ҳамоҳангсозии Корҳои Илмӣ таҳқиқотӣ ва таълимӣ методии МДТ “ДТБКСТ ҚТ” ба ҷоп тавсия шудааст (иқтибос аз суратчаласа №2 аз санаи 15.05.2025 сол).

Тақризгарон:

Раҳимов Зақрия Яҳяевич – профессори фахрии кафедраи кардиология бо курси фармакологияи клиникии МДТ “ДТБКСТ ҚТ”, “Корманди шоистаи Тоҷикистон”, н.и.т.

Одинаев Шухрат Фарҳодович - мудири кафедраи бемориҳои дарунии №1 МДТ “ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино”, д.и.т., дотсент.

Хуруфчи:

Нозиров Азизҷон Ҷамшедович – табиб-кардиолог, муовини сартабиб оиди табобат ва корҳои ташкилию методии МТТ ҚДММ “Парастор-2014”.

Дастури таълимӣ-услубӣ барои табибони бемориҳои дил, терапевтҳо, табибони оилавӣ, ихтисосгирандаҳои аввалия, ординатору аспирантҳо, инчунин, доираи васеи табибони гуногун, ки донишу малакаи худро нисбати бемории мазкур васеъ меҷӯянд кард, пешбинӣ шудааст.

Дастури мазкур хонандаро бо мафҳум, сабабу омилҳо, зинаҳои пайдоиш, таснифоту ташхисот ва пешгирию пешгуи бемории ишемиявии дил шинос ва ё дониши пештар андӯхтаи ӯро сайқал дода, бо гузаштани тестҳои санҷишӣ аз дараҷаи азхуд намудани маводи мазкур ӯ огоҳӣ пайдо менамояд.

Бо забони тоҷикӣ дастрас гардидани дастур ба хонанда имкони боз ҳам беҳтар азхуд намудани маводи мазкурро дода, барои дуруст омода намудани ҳуҷҷатҳои тиббӣ, ки ба бемории мазкур алоқаманданд, ёрӣ мерасонад.

МУНДАРИЧА

Руйхати ихтисорот	4
Сарсухан	5
Машғулияти 1. Бемории ишемиявии дил: мафҳум, паҳншавӣ, сабабҳо, омилҳои хавф	6
1.1. Мафҳуми бемории ишемиявии дил	6
1.2. Паҳншавӣ	6
1.3. Сабабҳо	7
1.4. Омилҳои хавфи беморӣ	8
Машғулияти 2. Зинаҳои инкишоф (механизм), таснифот, оризаҳои эҳтимолӣ ва нишонаҳои клиникӣи бемории ишемиявии дил ...	12
2.1. Зинаҳои инкишофи (механизм) бемории ишемиявии дил	12
2.2. Таснифот	13
2.3. Оризаҳои эҳтимолӣ	15
2.4. Нишонаҳои клиникӣи беморӣ	16
Машғулияти 3. Ташхисот, табобат, пешгирӣ ва пешгӯии бемории ишемиявии дил	18
3.1. Ташхисоти бемории ишемиявии дил	18
3.2. Табобат	21
3.3. Пешгирӣ	23
3.4. Пешгӯии беморӣ	23
Тестҳои санҷишӣ	25
Калиди ҷавоб ба тестҳо	30
Адабиёт	31

РУЙХАТИ ИХТИСОРОТ

БДР - бемориҳои дилу рағҳо

БИД - бемории ишемиявии дил

ДДТТ - Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон

ДТБКСТ - Донишкадаи таҳсилоти баъдидипломии кормандони соҳаи тандурустӣ

ИМА - Иёлоти Муттаҳидаи Амрико

ИФАТ - ингибиторҳои ферменти ангиотензин-табдилдиҳанда

ЛПЗП - липопротеидҳои зичиашон паст

МДТ - Муассисаи давлатии таълимӣ

МУИК АИТ - Маркази умумирусиявии илмӣи кардиологӣи Академияи илмҳои тиббӣ

ТМР - томографияи магнитӣи резонансӣ

ТПЭД - томографияи позитронӣи эмиссионӣи дил

ТУТ - Ташкилоти умумичаҳонӣи тандурустӣ

ФР - Федератсияи Россия

Хс - холестерин

ХсУ - холестерини умумӣ

ҚТ - Ҷумҳурии Тоҷикистон

ШВБ - шохиси вазни бадан

SCORE - Systematic Coronary Risk Evaluation

САРСУХАН

Бемории ишемиявии дил (БИД) дар сохтори бемориҳои дилу раг пас аз фишорбаландии шараёни яке аз чойҳои аввалро ишғол намуда, дар фарқият аз фишорбаландӣ, ӯ дар баробари сахм дар беморшавӣ, роли муйянсозро, инчунин, дар нишондодҳои ғавт ва маъубшавии аҳолии мебозад. Ҳамин тавр, БИД дар муқоиса ба тамоми бемориҳои дилу раги мавҷуд буда яке аз патология ва проблемаи мубрами аҳамияти калони иқтисодию-иҷтимоӣ дошта ба ҳисоб меравад.

Асри XXI бо омадани тибби далелнок дар ивази тибби клиникӣ фарқкунанда мебошад, ки асосан ба таҳлили илмии натиҷаҳои мета-таҳлилҳои таҳқиқотҳои назоратшавандаи рандомизатсиявӣ таъя менамояд. Аз ҳамин лиҳоз, нигоҳ ба бисёр паҳлуҳои проблемаи мазкур ҳамасола пурра набошад ҳам, каме мавриди ислоҳот қарор мегирад ва, вобаста ба ин, бисёре аз китобҳои дарсӣ ва дастуру тавсияҳои клиникӣ аз нав мавриди боздид ва таъбу нашр қарор мегиранд. Ёдовар мешавем, ки нашри китобҳои дарсӣ ва адабиётҳо аз рӯйдодҳои илмӣ, аз он ҷумла, аз дастовардҳои, ки дар даҳсолаҳои охир ба даст меоянд, ҳамеша қафо мемонад.

Вобаста ба ин, бо нашри дастури таълимию услубии мазкур меҳоме каме ҳам бошад сатҳи донишу малакаи табибон, донишҷуёну ординаторҳо ва аспирантҳоро дар масъалаҳои ташхису табобати бемории мазкур васеъ ва пурра намоем.

Тамоми мавод ва ахбороте, ки дар ин дастури талимию услубӣ ҷамъ оварда шудааст аз таҷрибаи муаллифон, кормандони кафедраи кардиология бо курси фармакологияи клиникӣ, дастовардҳои солҳои охир, ки ба омӯзиши проблемаи мазкур бахшида шудаанд, сарчашма мегиранд.

МАШҒУЛИЯТИ 1. БЕМОРИИ ИШЕМИЯВИИ ДИЛ: МАФҲУМ, ПАҲНШАВӢ, САБАБҲО, ОМИЛҲОИ ХАВФ

1. Мафҳуми БИД

Бемории ишемиявии дил (лотинӣ — morbus ischaemicus cordis, юнонӣ — исхаймиа — «ишемия», исхо — «боздоштан, тавақуф додан» ва айма — «хун») (ТББ 10 — I 20 - I 25; ТББ 11 — ВА 40 ВА — 60) — ин иллатёбии миокард мебошад, ки дар натиҷаи вайроншавии мувозинати байни татаботи метаболикии мушакҳои дил ва хунгардиши коронарӣ ба вучуд меояд (ТУТ, 1979).

1.2. Паҳншавӣ

Бемориҳои дилу раг (БДР) дар ҷаҳон сабаби асосии фавти ғайримачбурӣ ба ҳисоб мераванд. Дар сохтори фавти БДР, БИД ҷои аввалро ишғол намуда, дар соли 2020 дар миқёси ҷаҳон ӯ ҷони 126 млн одамонро (16% аз тамоми фавтҳо) аз байн бурдааст. Мардҳо нисбат ба занҳо бештар ба БИД гирифторанд. Мутобиқи маълумотҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ), фавт аз БИД аз ҳама беш дар Россия, Украина ва Иёлоти Муттаҳиди Амрико (ИМА) ба қайд гирифта шудааст.

Басомади БИД вобаста ба синну сол яку яқбора афзун мегардад: дар занҳо аз 0,1 то 1%-ро дар синну соли 45-54 сола, аз 10 то 15%-ро дар синну соли 65-74 сола, дар мардҳо бошад, аз 2 то 5%-ро дар синну соли 45-54 сола ва аз 10 то 20%-ро дар синну соли 65-74 сола, ташкил медиҳад.

Тахминан дар 1 аз 20 одами синну соли аз 20 сола боло БИД вомехӯрад. Вале, бисёре аз одамон, бинобар он, ки дарди қафаси синнаро надоранд, то он вақте, ки рағҳои коронарӣ танг ва ё маҳкам нагарданд, ки ин хуруҷи дилро ба вучуд меорад ва ё то он даме, ки дилашон аз таппиш намонад, онҳо намедонанд, ки дорои БИД мебошанд.

Паҳншавии БИД дар Федератсияи Россия (ФР) мувофиқи маълумотҳо аз мурочиат >7,6 млн-ро дар соли 2022 ташкил дод, ки ~ 5,2% аҳолии онро дарбар мегирад. Ҳиссаи шаклҳои шадиди БИД дар сохтори ӯ 18,2%, яъне 307,4 дар 100 ҳазор нафар, шаклҳои музмин бошад, 81,7%-ро ташкил дод. Дар сохтори беморшавӣ вазни қиёсии БИД дар байни тамоми бемориҳо 3,0%-ро, дар байни бемориҳои системаи хунгардиш бошад, 20,1%-ро ташкил дод. Аз ин нишондод дар байни калонсолон 63,3%-ро шаклҳои музмини БИД ташкил доданд.

Дар ФР, дар сохтори фавт аз тамоми бемориҳо, дар соли 2022 БИД 23,8%, дар сохтори бемориҳои системаи хунгардиш бошад, 54,2%-ро ташкил дод. Аз теъдоди умумии беморони дорои БИД >180 ҳазорро гирифтронии сактаи миокард ташкил додаанд, ки аз ин теъдод >50 ҳазорашон (27,6%) фавтидаанд.

Мувофиқи маълумотҳои расмӣ Маркази ҷумҳуриявии омори тиббӣ ва ахбороти Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон беморшавии умумӣ аз БИД дар анҷоми соли 2023 ва оғози соли 2024-ум 181,5 дар 100 ҳазор аҳоли (18479 нафар), беморшавии аввалия бошад, 69,6 (7088 нафар)-ро дар 100 ҳазор аҳоли ташкил дод.

Агар ба маълумотҳои натиҷаи таҳқиқотҳои скринингии аҳолии аз 15 сола боло, ки ташҳиси 16500 нафарро дарбар гирифта буд назар афканем, пас мебинем, ки паҳншавии воқеии БИД дар байни аҳоли 9100-ро дар 100 ҳазор аҳоли ташкил медиҳад (Нозиров Қ.Ҳ., 2018). Ин адад нисбат ба нишондодҳои соли 2018, ки аз сарчашмаҳои расмӣ ба даст омадаанд 6,8 маротиба зиёд мебошад. Ин гувоҳӣ аз он медиҳад, ки маълумотҳои аз натиҷаҳои мурочиат ба даст омада, ҳеҷ гоҳ асли воқеият, яъне паҳншавии воқеии ин ва ё он беморию дода наметавонанд (“қуллаи айсберг” – “қуллаи куҳи яхин”-ро нишон медиҳанд).

Танҳо скринингҳои илман дуруст ва ботартиб ба нақша гирифта шуда, метавонанд асли воқеият (“қулла ва қисми зернобии айсберг”)-ро нишон диҳанд.

Таркиби сабабҳои фавт аз шаклҳои гуногуни БИД, аз дуруст ороиш додани шаҳодатномаҳои фавт, ҷобачогузори пайдарпаии мантиқан дуруст ва интиҳоби аввалин сабабе, ки мутобиқи Таснифоти байналхалқии бемориҳо, боздиди 10-ум, ба фавт оварда расонидааст, вобастагӣ дорад.

1.3. Сабабҳо

Сабабҳои асосие, ки ба монетагӣ дар маҷрои хун оварда мерасонанд инҳоянд:

1. Атеросклерози шараёнҳои коронарӣ (>90%);
2. Тангшавӣ (спазм);
3. Судабандӣ.

Инчунин, ба БИД чунин ҳолат ва бемориҳо оварда расонида метавонанд:

- Бемориҳои гадуи сипаршакл;
- Калоншавии андозаҳои дил дар заминаи фишорбаландӣ ва бемориҳои дигар;
- Баланд ва ё пастшавии устувори фишори шараён;
- Баландшавии лахташавии хун, афзуншавии хавфи судабандӣ.

1.4. Омилҳои хавф

Омилҳои хавфи БИД – ин он омилҳои мебошанд, ки метавонанд эҳтимолияти пайдоиши ин патологияро баланд бардоранд ва/ва ё ба ҷараёни беморӣ таъсири манфӣ расонанд. Ду гурӯҳ омилҳои хавфи БИД-ро фарқ мекунанд – тағирнопазир ва тағирпазир.

Омилҳои тағирнопазир – ин омилҳои мебошанд, ки тавассути тадбирҳои пешгирӣ тағир ва ё беҳсозӣ намешаванд, вале ҳангоми муайянсозии гурӯҳҳои хавфи БДР-и ҳар як фард онҳоро ҳатман ба инobat мегиранд. Ба ин омилҳо шомил мешаванд:

- *Синну соли калон.* Хавфи сар задани БИД баъди 55 солагӣ дар мардҳо ва баъди 65 солагӣ дар занҳо баланд мегардад.
- *Ҷинси мард.* Мутобики маълумотҳои то имрӯз ба даст омада эҳтимолияти БИД дар мардҳо баландтар аст, аммо сабаби чунин вобастагӣ то ҳол муайян нест. Тахмин карда мешавад, ки ин ба шаклҳои ирсии Y-хромосомаҳо вобастагӣ дорад.
- *Қатъи ҳайз.* Дар занҳо дар давраи пеш аз ҳайзӣ падидаҳои ҷиддии БИД, ба мисли сактаи миокард ва манъшавии нобаҳангоми дил нисбатан кам вомерхӯранд. Пас аз қатъи ҳайз басомад ва вазнинии БИД то 3 маротиба меафзояд.
- *Таърихи оилавии БДР.* Агар дар одам ҳешу табори катори якум (падар, модар, бародар, хоҳару апа) таърихи бармаҳали БДР-ро дошта бошанд, ин ҳам омили бевоситаи хавф ҳисобида мешавад. Огози бармаҳал шуморида мешавад агар падидаҳои бемориҳои дилу раг то 55 солагӣ дар падар ва ё бародар ва то 65 солагӣ дар модар ва ё хоҳару апаҳо ба вучуд оянд.

Инчунин, ба омилҳои дигари тағирнопазир дохил мешаванд мансубияти қавму наҷодӣ (мисол, дар сиёҳпӯстон хавфи фишорбаландӣ ва

инсулт, норасони музмини гурдаҳо баланд аст) ва чуғрофӣ (мисол, басомади бештари инсулт ва БИД дар Россия, Аврупои Шарқӣ ва мамлакатҳои Балтика; хавфи пасти БИД дар Чин).

Омилҳои тағирпазир. Бисёре аз омилҳои хавфи БДР-ро метавон тавассути чораҳои пешгирии ва ё назорати бемориҳои ҳамрадиф паст ва ё аз байн бурд. Дар байни ин гурӯҳ якчанд омилҳои асосии хавф мавҷуд аст, ки дар поён омадаанд ва дар ҷамъ ба зиёда аз нисфи фавтҳои, ки аз БДР ба вуҷуд меоянд, ҷавобгаранд.

- *Вайронишавии мубодилаи липидҳо (дислипидемия).* Сатҳи баланди холестерин умумӣ (ХсУ) ва холестерини (Хс) липопротеидҳои зиччиашон паст (ЛПЗП) («холестерини бадсифат») хавфи пайдоиши БИД-ро афзун менамоянд.
- *Фишори баланди шараёнии (фишорбаландии шараёнии) —* ба дил ва рағҳо сарбориро ба вуҷуд меорад. Ин омил аз ҳама беш исботгаштаи бемориҳои дилу рағ, аз он ҷумла, фавт аз БИД ба ҳисоб меравад. Меъёрӣ шуморида мешавад фишори шараёнии аз 120/80 мм сут. сим. поён.
- *Тамокукашӣ.* Қатъи тамокукашӣ — яке аз тадбири аз ҳама муҳими пешгирии БИД ба ҳисоб меравад. Имтиёзҳои дасткашӣ аз тамокукашӣ новобаста аз он, ки то имрӯз чи қадар тулонӣ инсон ӯро кашидааст, ба вуҷуд меоянд. Мутобиқи маълумоти ТУТ, 23% фавтҳои, ки аз БИД ба вуҷуд меоянд ба тамокукашӣ вобастагӣ дошта, давомнокии умри тамокукашонии синну соли 35-69 соларо ин одати бад, ба ҳисоби миёна, то 20 сол кам мегардонад. Фавти нобаҳангом дар байни нафароне, ки 1 ва зиёда қуттӣ сигорро мекашанд то 5 маротиба, нисбат ба онҳое, ки онро истифода намебаранд, зиёд аст.
- *Вазни барзиёд.* Одатан вазни барзиёд ҳафи сар задани дигар омилҳои ҳоро афзун мегардонад. Тавассути ченкунии шохиси вазни бадан метавон вазни баданро муайян намуд ($ШВБ = \text{вазн, кг/қад, м}^2$).
- *Диабети қанд.* Дар нафарони дорони диабети қанд 2-8 маротиба эҳтимолии гирифтورشавӣ ба БДР, нисбат ба он нафароне, ки дар ҳамин синну соланду, вале диабетро надоранд, зиёд мебошад.

- *Тарзи камҳаракати ҳаёт.* Мутобиқи таҳқиқоти глобалии INTER-HEART, мавҷуд набудани фаъолиятҳои мунтазами ҷисмонӣ то 12% хавфи сактаи аввалинбораро афзун мегардонад. Ҳатто машқҳои сарбории миёна инсонро аз БИД ва фавт ҳимоя месозанд.
- *Истифодаи барзиёдӣ нушокиҳои спиртдор.* Меъёрҳои истифодаи нушокиҳои спиртдор: 15 мл спирти этил барои мардҳо, ки ба 40-50 мл арақ, коняк, 150 мл вино ва 0,5л оби чав рост меояд, дар занҳо – 2 маротиба камтар.
- *Стресси сахт ва ихтилолҳои руҳӣ.* Ин омил ба инкишофи бармаҳали атеросклероз, сар задани сактаи шадиди миокард ва фавти нобаҳангом мусондат мекунад. Алоқаи байни стресс ва атеросклероз метавонад мустақим, ва ё ғайримустақим – тавассути омилҳои дигари хавф бошад, мисол тамокукашӣ, ё ки набудани сарбориҳои ҷисмонӣ.
- *Ғизои нодуруст.* Баъзе аз хусусиятҳои хӯрок метавонанд хавфи БИД-ро афзун гардонанд. Алоқаи байни холестерини ғизо ва инкишофи БДР то кунун бо пуррагӣ маълум нест. Ғизое, ки имрӯз аҳолии кишвари мо ба ӯ бештар таваҷҷуҳ намудааст, яъне истифодаи бештари хӯрокҳои дорои гушти сурх ва рағани ҳайвонот, ба хусус хомшурпо, истифодаи миқдори бениҳояи ками меваю сабзавоти тар, инчунин истифодаи нағштани гуногунтаркибӣ дар ғизо, бениҳоят ташвишвар аст.
- *Бемориҳои ҳамрадиф.* Баъзе бемориҳо ба омилҳое, ки пайдоиши атеросклероз ва ишемияро баланд месозанд, таъсир мерасонанд. Ба чунин ҳолат ва бемориҳо мансубанд:
 - ✓ презклампсия – метавонад дар зани ҳомила пайдо шавад ва фишорро афзун гардонад;
 - ✓ бемориҳои аутоиммунӣ – равишҳои илтиҳоб дар организм ба баландшавии хавфи фавт аз БИД ва сактаи миокард оварда мерасонанд;
 - ✓ апноэ дар хоб – таваккуфҳои доимии нафас дар хоб поёнравии яку яқбораи сатҳи оксигени хунро ба вучуд оварда, фишори шараёнро баланд ва таъсири манфиро ба системаи дилу рағ мерасонад;

- ✓ бемории музмини гурда (норасоии музмини гурда) – Фонди миллии гурда (National Kidney Fondation) аз 2002 сол тавсия додааст, ки тамоми зинаҳои бемориҳои музмини гурдаро бояд омили хавфи БИД шуморид;
- ✓ бемориҳои стоматологӣ – ҳолати бади ковокии даҳон ва бойдиҳии дандонҳо метавонанд бо баландшавии басомади миёнаи БДР алоқаманд бошанд, ин метавонад аз ҳама беш ба таъсири илтиҳоби такҷонии системавӣ вобастагӣ дошта бошад. Мавзӯи мазкур то кунун пурра омухта нашудааст.

МАШҒУЛИЯТИ 2. ЗИНАҲОИ ПАЙДОИШ, ТАСНИФОТ, ОРИЗАҲОИ ЭҲТИМОЛӢ ВА НИШОНАҲОИ БЕМОРИИ ИШЕМИЯВИИ ДИЛ

2.1. Зинаҳои пайдоиш

Зинаҳои БИД:

1. Пеш аз беморӣ — замшавии омилҳои хавф ва тангшавии шараёнҳои коронарӣ $<50\%$;
2. Ишемияҳои кӯтоҳмуддат — на зиёда аз 15-20 дақиқа;
3. Дистрофикӣ — некрозӣ — хуруҷҳои стенокардия то 40 дақиқа тул мекашанд;
4. Склеротикӣ — манбаҳои некроз.

Сабаби асосии пайдоиши БИД атеросклероз мебошад. Иллатбардории қабатҳои дарунии (эндотелий) шараёнҳои коронарӣ аз таъсири омилҳои гуногун, аз он ҷумла, сатҳи баланди холестерин (хусусан ЛПЗП), фишорбаландӣ, диабет ва ғ. ба пайдоиши лавҳа оварда мерасонанд. Сараввал лавҳа дар танаи раг афзоиш (на дар ковокии он) ёфта, танҳо диаметри онро калон месозад, аз ҳамин рӯ дар бемор нишонаҳои клиникӣ метавонанд набошанд. Вале, лавҳаи атеросклерозӣ оҳиста-оҳиста суроҳии рагро танг намуда, дар натиҷа ба бемории ишемиявии дил оварда мерасонад — ҳолате, ки мушакҳои дил хуни шараёнии аз оксиген бойро бинобар паст ва ё қатъшавии хуншорӣ қабул карда наметавонанд. Дар зинаҳои пазмонгаштаи инкишофи атеросклероз ихтилолҳои боз ҳам ҷиддӣ дар системаи лахташавии хун сар мезананд. Дар болои лавҳа шикастҳои майда пайдо шуда, шаронти фароҳамро барои часпидани тромботситҳо ва пайдоиши судда (тромб) ба вучуд меорад. Ин сабаби танг ва ё пурра маҳкам шудани суроҳии раг гашта, ба стенокардия ва ё сактаи миокард оварда мерасонад.

Тангшавиҳои назаррас, ҳатто бо пурраги маҳкамшавии раг на дар ҳама ҳолатҳо ба сактаи миокард оварда мерасонанд: мунтазам такроршавии ҳолатҳои ишемикӣ метавонад хунгардиши коллатералиро ба вучуд орад, ки ин оқибатҳое, ки аз маҳдудгардии хуншорӣ тавассути шараёни асосӣ ба вучуд меоянд, сабук гардонад (преконденсионии ишемикӣ).

Бемории ишемиявии дил дар бисёр мавридҳо пеш аз он, ки нишонаҳояш назаррас бошанд, дар давоми даҳсолаҳо инкишоф меёбад.

2.2. Таснифот

Муайянсозӣ ва таснифоти шаклҳои БИД дар мамлакатҳои гуногун, инчунин, вобаста ба тавсияҳои фарқкунанда мебошанд, вале маҳаки умумӣ – дараҷаи тангшавии (стеноз) шараёни коронарӣ мебошад. Вобаста аз ин се намуди БИД мавҷуд аст:

1. Бо монеа (обструктивӣ): рағҳои хунгард анча танг ($\geq 50\%$) ва ё муҳосирагашта.
2. Бе монеа (ғайриобструктивӣ): рағҳои хунгард $< 50\%$ танг – ин аз ҳисоби ба рағҳои боз ҳам хурдтар тақсим шудани онҳо, ва ё аз ҳисоби хусусиятҳои кори мушакҳои дил.
3. Худ ба худ ҷудошавии шараёнҳои коронарӣ, яъне кафидани рағҳои коронарии дил.

Аз руи хусусияти ҷараёнگیرӣ, БИД метавонад шадид ва музмин бошад:

1. Шадид – алоими коронарии шадид – ин яку яқбора кам гаштани воридшавии хун тавассути рағҳо ба миокард.

2. Музмин – чун стенокардия, дар норасоии музмини дил, вайроншавии назм вонамуд мешавад.

Падидаи аз ҳама ҷиддии БИД – ин сактаи миокард мебошад, ки аз ҳама беш ба фавт оварда мерасонад ва ҳар 1-то аз 5 хуруҷҳои дил бе нишона мегузарад.

Таснифоти БИД дар асоси тавсияҳои коршиносони ТУТ (1979), аз ҷониби Маркази умумирусиявии илмии кардиологӣ Академияи илмҳои тиббӣ (МУИК АИТ) ФР барои истифода пешниҳод гаштааст (ҷадвали 1).

Ҷадвали 1. Таснифоти БИД (МУИК АИТ ФР; ТУТ, 1984)

1.	Фавти нобаҳангоми коронарӣ (таваккуфи аввалияи дил)
2.	Стенокардия
2.1.	Стенокардияи шиддати устувор (бо нишондиҳии синфҳои вазифавии I-IV)
2.2.	Стенокардияи ноустувор
2.2.1.	Стенокардияи аввалинбор пайдошуда
2.2.2.	Стенокардияи тадриҷан шиддатёбанда
2.2.3.	Стенокардияи бармаҳали пас аз сактавӣ ва ё пас аз ҷарроҳӣ
2.3.	Стенокардияи стихиявӣ (вазоспастикӣ, Принсметал)
3.	Ишемияи бедарди миокард

4.	Стенокардияи микроваскуляри (алоими дилии X)
5.	Сактаи миокард
5.1.	Сактаи миокард бо дандонаи Q (калонманбаъ, трансмуралӣ)
5.2.	Сактаи миокард бе дандонаи Q (хурдманбаъ)
6.	Кардиосклерози пас аз сактавӣ
7.	Норасоии дил (бо нишондиҳии шакл ва зинаҳо)
8.	Вайроншавии назми дил ва гузарониш (бо нишондиҳии шакл, ва ё намуд)

Фавти коронарии нобаҳангом – ин фавти ногаҳонии табиест, ки аз сабабҳои дилӣ дар давоми 1 соат аз огози нишонаҳо дар бемори дорои бемориҳои дил ва ё бе мавҷудияти бемориҳои дил ба вучуд омадааст.

Фавти нобаҳангоми коронари метавонад бо мувафакият ба начотёбӣ, ва ё фавти биологӣ анҷом ёбад.

Стенокардия – ин лаҳзаҳои гипоксияи миокард буда, дар натиҷаи ишемияи даргузари $\bar{y}$ пайдо мешавад. Одатан ба $\bar{y}$ дардҳои зеркунанда, фишороваранда, зеркунандаи паси тӯшӣ хос буда, онҳо ба дасти чап, мавзеи байнибелақӣ, гардан, ҷоғи поён, эпигастрий ва баъзан ба қисмати рости қафаси синна интишор меёбанд.

Пас аз ягон лаҳза хуншорӣ барқарор ва миокард аз нав вазифаи худро иҷро менамояд.

Ишемияи бедарди миокард – ин лаҳзаҳои депрессияи бандаки ST мебошад, ки ба ишемия хос буда, дар заминаи атеросклерози рағҳои дил пайдо ва ҳангоми монитorkунонии холтерӣ ва ё тестҳо бо сарборӣ дарёфт, вале нишонаҳои субъективии нофориамия дардро ба вучуд намеоранд. Равиши мутлақо бенишонаи БИД дар 5% беморон ташхис карда мешавад.

Стенокардияи микроваскуляри (алоими «X») – шакли БИД-ест, ки ба иллати шараёнҳои майдаи коронари вобастагӣ дошта, беморон нишонаҳои хоси стенокардиаро доранд, аммо ҳангоми коронарография ин тағиротҳо муайян карда намешаванд.

Сактаи миокард – ин шакли шадиди БИД буда, дар натиҷаи якуякбора вайроншавии хуншорӣ дар шараёнҳои коронарии миокард, манбаи некроз пайдо мешавад.

Сакта метавонад шакли интрамуралӣ (бе дандонаи Q), ки раванди то ба охир ба анҷом нарасидаи сакта ба ҳисоб меравад ва трансмуралӣ (бо

дандонаи Q)-ро дошта бошад. Инчунин, вобаста ба ҷойгиршавӣ дар миокард намудҳои гуногуни сактаро фарқ мекунад. Кардиомиоситҳои фавтида аз нав барқарор нагашта, дар ҷои онҳо бофтаи пайваस्तкунанда, яъне из ба вучуд меояд.

Кардиосклерози пас аз сактавӣ – ин оқибати сакта, яъне нумӯи бофтаҳои изӣ дар ҷои кардиомиоситҳои фавтида мебошад. Дар ин давра из то ба охир мустаҳкам гашта, организми бемор ба шароити нави ғайолият мутобиқ мегардад. Ин қидъаи миокард иҷрои тамоми вазифаҳои худро қатъ менамояд, ки ин ба сар задани аритмияҳо, пайдоиши норасоии дил оварда мерасонад. Дар СБД бандаки ST изобарқӣ, дандонаи T-манфӣ, дандонаи Q бошад, возеҳ мебошад.

Вайроншавии гузарониш ва назми дил – дар бисёр мавридҳо ҳамчун оризаи ишемия ва ё кардиосклероз ба вучуд омада, алоқаи зичии сабабу натиҷавӣ он вақт муайян карда мешавад, агар аритмия ва ё муҳосира ҳангоми ишемия ва ё сакта ба вучуд оянд. Пайдоиши фибриллятсияи даҳлезҳо, экстрасистолияҳо, муҳосираҳои дил, вайроншавиҳои дараҷаҳои баланди меъдаҷавии назм (дилзании меъдаҷавӣ, фибриллятсияи меъдаҷаҳо) хос мебошанд.

Норасоии дил – ин вайроншавии сохтор ва ё вазифаи дил мебошад, ки дар натиҷаи он дил қудрати бо оксиген таъмин намудани организмро бо фишори меъёрии пуркунии меъдаҷаҳо надошта, ин раванд танҳо бо арзиши афзунгардии фишори пуркунии дил ба даст меояд.

Норасоии дил оризаи БИД ба шумор рафта, бештар пас аз сактаи миокард, ҳангоми пайдоиши кардиосклероз ба вучуд меояд.

2.3. Оризаҳои эҳтимолӣ

Оризаҳои БИД метавонанд барои ҳаёт таҳдидкунанда бошанд, ва ё ба маънобӣ оварда расонанд. Ба ҷунин оризаҳо мансубанд: алоими қоронарии шадид (аз он ҷумла, стенокардия ва сакта), аритмияҳо, норасоии дил, садамаи дил ва таваккуфи нобаҳангоми дил.

Ночурии хуншорӣ ва воридшавии оксиген сохтор ва вазифаи кардиомиоситҳоро тағир дода, ин, дар навбати худ, ба ғайриҷубронӣ гаштани БИД оварда мерасонад:

- ♦ бадшавии мубодилаи нерӯ дар мушакҳои дил;
- ♦ миокарди «хобида»;

- ◆ баъдшавии вазифаи кашишхӯрӣ;
- ◆ кардиосклероз – дар ҷои кардиомиоситҳо нашьунамои бофтаи изӣ;
- ◆ ноустувории барқии миокард.

2.4. Нишонаҳои бемории ишемиявии дил

Хатари БИД дар он аст, ки на ҳама одамон нишонаҳои хоси онро доранд. Дар баъзе беморон беморӣ бе нишон, ҳатто то сар задани сактаи миокард ҷараён дорад. Нишонаҳои БИД ва болоравии он бештар дар шакли стенокардия ва нафастангӣ ҳангоми фаъолияти ҷисмонӣ падида мегарданд. Ҳангоми стенокардия инсон бештар зеркуниҳои дарднокро дар қафаси синна ҳис мекунад, инчунин, дард метавонад дар мавзеи китф, даст, гардан, ҷоғи поён, тахтапушт ва ё мавзеи эпигастрий ҷойгир бошад, ҳангоми стресс афзун ва пас аз хобравӣ ва ё истироҳат бартараф гардад. Ба ғайр аз ин, беморон метавонанд ба нафастангӣ, хусусан, ҳангоми ҳаргуна фаъолиятҳо, номурағабии қори дил, ҳиссиёти манъшавӣ дил ва ғ. шикоят дошта бошанд. Чунин нишонаҳо танҳо ба ин беморӣ хос буда наметавонанд, ва бисёре аз беморон ба онҳо таваҷҷуҳи хос наменданд.

Ҳангоми ҳолатҳои шадиди коронарӣ, ба мисли сактаи миокард ба нишонаҳои дар боло зикршуда метавонанд: арақи хунук, сарчархзанӣ, дилбеҳузурӣ, вайроншавии хоб, камқувватии назаррас, торикшавии пеши чашмон, беҳушшавӣ ва ғ. илова гарданд. Таъҷубовар он аст, ки нишонаҳои беморӣ вобаста ба ҷинс фарқкунанда мебошанд: занҳо нисбат ба мардҳо камтар нишонаҳои БИД-ро дошта, камтар ҳангоми хуруҷҳои дил дарди қафаси синнаро ҳис мекунанд, ба онҳо мондашавӣ ва дард дар шикам хос аст.

Вобаста ба шакл ва дараҷаи вазнинии БИД нишонаҳои объективии ӯ гуногун мебошанд:

- парридани ранги пӯст;
- кабудшавии нӯги бинӣ, гӯшҳо, ангуштон;
- варам дар пойҳо;
- аритмия;
- шувосҳои дил;
- арақи хунук.

Ҳангоми ғавти коронарии нобаҳангом бошад, яку якбора чунин нишонаҳо — бе сабаб беҳушшавӣ, қатъ гаштани нафас ва таппиши дил сар мезананд. Зарбаҳои дил шунда намешаванд, гавҳаракҳои чашмон васеъ, пуст ранги сафеди хокистарангро мегирад.

380424

МАШҒУЛИЯТИ 3. ТАШХИСОТ, ТАБОБАТ, ПЕШГИРӢ ВА ПЕШГӢИ БЕМОРИИ ИШЕМИЯВИИ ДИЛ

3.1. Ташхисот

БИД-ро дар асоси нишонаҳо ва таҳлилҳо ташхисгузорӣ менамоянд: табиб бояд беморро оиди одатҳои ғизо, фаъолияти ҷисмонӣ, бемориҳои гузаронида, таърихи оилавӣ ва ғ. бипурсад ва омилҳои хавфи дилу рағ-хоро баҳо диҳад.

Ба ғайр аз нишонаҳои дар боло қайд гаштаи беморӣ, барои ташхис-гузории БИД чунин усулҳои дар поён зикршударо истифода мебаранд.

Таҳлили хун: таҳлили сатҳи холестерини умумӣ, холестерини «бад-сифат» (липопротеидҳои зиччиашон паст ва ниҳоят паст), триглитсерид-ҳо, глюкоза ва сафедаи С-реактивӣ – ҳамчун маркёри илтиҳоб, фермент-ҳои хос: креатинфосфокиназа, тропонин, миоглобин.

Сабти барқии дил (СБД) – усул тахмин мекунад сабти фаъолияти барқии дилро. Ӯ метавонад иллати дил, ки аз ишемия бардошт шуда бошад, суст ва ё тез зарабонӣ, аритмияҳо, муҳосираҳо ва ғайраро нишон диҳад. Вале, ҳангоми мавҷуд набудани ҳолатҳои хуруҷи БИД, СБД метавонад ягон тағиротро нишон надиҳад.

СБД барои скрининги бемориҳои дил дар нафароне, ки хатари пасти инкишофи онро доранд, гузаронида намешавад.

Мониторкунонии холтерӣ – қайди шабонарузии СБД тавассути дастгоҳе, ки ба тани бемор маҳкам карда мешавад. Усул имкони дар-ёфти лаҳзаҳои пайдоиши ишемия, омилҳои ангиезиш, давомнокии хуруҷ ва алоқаи онҳо ро медиҳад.

Тестгузаронии стрессӣ – моҳияти он дар назорати беморие, ки зери сарборӣ қарор гирифтааст асос ёфтааст, барои мисол, ҳангоми машқ-куниҳо дар сурате, ки набз баланд гаштааст. Ҳангоми сарборӣ ва пас аз он СБД-ро сабт мекунанд. Тестгузаронии стрессӣ чӣ ҳангоми ташхисоти аввалия (бахусус дар ҳолатҳои, ки дард дар қафаси синна, дилзанӣ, арит-мияҳо, зуд-зуд сарчархзаниҳо ҷой доранд), ва чӣ барои баҳогузории сат-ҳи сарбории беҳатар – ҳангоми БИД ва ё хуруҷи дилии бартарафгашта гузаронида мешавад. Шакли боз ҳам возеҳи ин тест – стресс-тести радио-нуклоидӣ мебошад, ки ҳангоми гузаронидани ӯ ба хуншорӣ радиотрей-

сер — пайваста бо тамғаи радиофаълӣ, аз ҳама беш изотопи фтор (фтор-дезоксиглюкоза, флурпиридаз) илова мекунамд.

Молекулаҳои радиотрейсер дар он минтақаҳое зам мешаванд, ки дар он ҷой илтиҳоб мегузарад. Дар ин маврид чашмраскунонии кори дилро дар ҳолати оромӣ ва сарборӣ тавассути томографи позитронию — эмиссионӣ ва, баъзан, ташхисро бо томографи магнитию резонансӣ якҷоя истифода мебаранд.

Эхокардиография — лапишҳои овозӣ, ахборотро оиди равиши кашишхӯриҳои дил медиҳад. Таҳқиқот андоза ва шакли дил, кори даҳлез ва медачаҳои дил ва дарғотҳоро нишон медиҳад. Ин усул имкони муайянсозии минтақаҳои дил, ки дар он ихтилолҳои хуншорӣ ҷой доранд, иллатҳои пештар бардошта ва ихтилолҳоро дар кашишхӯрии мушакҳои дил медиҳад.

Рентгенографияи қафаси синна (дил, шӯшҳо ва рағҳои хунгард) тасвири дилро дар қафаси синна, ҷойгиршавии ӯ, андозаҳои меъдача ва даҳлезҳо, инчунин, метавонад нишонаҳои норасоии дилро дарёфт намояд. Шуонидиҳои рентгенӣ бо вояҳои баланд барои ҳаёт, бинобар эҳтимолияти баланди сар задани бемориҳои саратонӣ хатарнок аст, вале ҳангоми тазриқҳои стандартӣ вояи шуогузаронӣ хатари иловагиро ба организм намерасонад.

Ангиографияи коронарӣ имкони таҳқиқоти дилро пас аз воридсозии даруниваридии моддаи контрастӣ дар заминаи йод тайёршуда, тавассути кастара, пас аз муоинаи пешакии бемор ба бардошти маводҳои йоддор, медиҳад. Ангиография метавонад таинот дошта бошад пас аз натиҷаҳои шубҳаноки СБД ва стресс-тестҳо, бо инобати шикоятҳо ба дард ва нишонаҳои дигари ба беморӣ хос.

Томографияи компютери дил имкон медиҳад дуруштшавӣ ва тангшавии шараёнҳои калонро дарёфт намояд, инчунин, замшавии калтсийро дар деворҳои чашмрас намояд, ки нишонаи бармаҳали БИД-и эҳтимолӣ ба ҳисоб меравад. Бартарии возеҳи усул — ин ғайриинвазивӣ будани он нисбат ба ангиографияи контрастӣ мебошад.

Дар як қатор ҳолатҳо метавонанд усулҳои боз ҳам чуқур ва серхароҷоти таҳқиқот тавсия шаванд:

Томографияи магнитию резонансии (ТМР) дил – метавонад иллати бофтаҳо ва ё проблемаҳои ба хуншории дил ва рағҳои коронарӣ тааллуқдошта, инчунин тағиротҳои рағҳои майдаро дарёфт намояд. Усул метавонад ҳангоми ташхисоти иловагии БИД (бахусус БИД-и бе монета, бенишона) ва иллатҳои микрорағӣ истифода шавад. Мувофиқи қоида ТМР-и дилро барои аниқсозии натиҷаҳои дигар таҳқиқотҳои чашмраскунанда, ба хусус рентгени қафаси синна ва ё томографияи компютерӣ, таин мекунамд.

Томографияи позитронӣ эмиссионӣ дил (ТПЭД) – имкони баҳодихии хуншориро тавассути рағҳои майдаи коронарӣ ва бофтаҳои дил медиҳад, инчунин, барои ташхиси стенокардияи микроваскулярӣ (аломии Х) ва дигар патологияҳое, ки ба рағҳои майда алоқаманданд, истифода шавад.

БИД-и бенишона ва ё бемории рағҳои майда дар бисёр мавридҳо ташхис гузаронида намешавад, чунки бемор ва табибон наметавонанд омилҳои хавфро дуруст баҳо диҳанд, усулҳои «стандартӣ» ташхисот бошанд, ба ин патологияҳо ҳассосият надоранд. Ташхиси ин шаклҳои БИД бештар санҷишҳои инвазивӣ ва ё таҳассусиро, ба мисоли ТПЭД талаб менамояд, ки ин боз мамнуъҳои худро дорад ва барои ташхиси бисёриҳо дастрас намебошад. Ҳоло гуфтан мумкин нест то чӣ андоза таҳқиқотҳои скринингии БДР, аз он ҷумла ба беморони БИД-и бенишона, самараноканд. Ҳамзамон, мутобиқи тавсияҳои ташкилотҳои тиббии Иттиҳоди Аврупо ва ИМА, он амали асосие, ки бояд табиб ҳангоми муошират бо бемори бенишона гузаронад – ин баҳодихии хавфҳо бо истифодаи ҳисобкунак ва ҷадвалҳои махсус, мисол SCORE, мебошад. Вале, барои он, ки хавфҳо ҳисоби карда шаванд, на танҳо маълумотҳо оиди тарзи ҳаёти мариз ва оилаи ӯ, балки маълумотҳои иловагӣ, ба мисоли сатҳи холестерини умумии хун, фишори шараёнӣ ва ғ. зарур мебошанд.

Масъалаи зарурати таҳлили маркёрҳои биологӣ ва истифодаи усулҳои дастгоҳӣ бо мақсади скринингҳои оммавӣ даҳсолаҳои охир мавриди муҳокимаи ғаёл қарор доранд. Ҳоло тадқиқотҳои минбаъда тавсияи таинотро танҳо барои беморони дорои хавфи БИД, мутобиқи ҷадвалҳои баҳодихии хавфҳо, медиҳанд. Барои беморони гурӯҳи хавф, масалан диабетикҳо, метавонанд тадбирҳои фардии скринингӣ, масалан чашмраску-

нонии замшавии калтсий дар шараёнҳои коронарӣ тавсия шаванд. Ҳангоми муоинаҳои ҳамасола ва ё диспансеркунонӣ баҳодихии омилҳои хавф ва хавфи хуруҷи дил дар дахсолаҳои наздик муҳим мебошад – дар вобастагӣ аз ин, табиб метавонад таҳқиқотҳои иловагиро таин намояд.

3.2. Табобат

Усулҳои табобат

Табобати бемории ишемиявии дил чунин чорабиниҳоро дарбар мегирад:

- ♦ ғайридоругӣ – танзими ғизо, реҷаи меҳнат ва истироҳат;
- ♦ дастгирии доругии миокард, таъсиррасонӣ ба омилҳои сабабӣ;
- ♦ барқарорсозии қобилияти гузаро будани суроҳии рағ тавассути ҷарроҳӣ.

Умуман табобати консервативӣ ва ҷарроҳии БИД-ро фарқ мекунанд.

Табобати консервативӣ:

- ♦ интиҳоби фаъолияти муносиби ҷисмонӣ бо мақсади нагирифтани вазни зиёдатӣ ва ё раҳой аз вазни барзиёд;
- ♦ парҳез – тавсияи мизи табобатии 10-ум дода мешавад. Амалия нишон дод, ки маҳдудияти ҷиддӣ ва доимии ҷарбҳои сершуда дар ғизо (равғани ҳайвонот дар кадом шакле, ки набошад) дар дурнамои наздик ва, бахусус, дурнамои дур ба натиҷаҳои бениҳоят хуб, ки ҳатто аз самараи ангиопластика беҳтар бошад, оварда мерасонад;
- ♦ дасткашӣ аз никотин, арақ.

Маводҳои доругиро барои табобати БИД тавассути чунин нақша интиҳоб менамоянд: зиддиагрегантҳо+β-адреномуҳосирагарҳо+статинҳо. Ин нақша метавонад ба тамоми зинаҳои пайдоиши БИД – атеросклероз, судда, ишемия таъсир расонад. Ҳангоми нишондод: нитратҳо, диуретикҳо, маводҳои зидди аритмиро низ, таъин мекунанд.

Қабули доруҳо якумра мебошад. Бемор зарурати давра ба давра гузаштани муоинаи кардиологро дорад – бо мақсади муносибкунонии табобат вобаста ба болоравии беморӣ ва ё самараҳои номатлуб аз қабули доруҳо.

- Доруҳои пасткунандаи сатҳи лахташавии хун: аспирин, ривароксатан, клопидогрел ва ғ. – бо ҳам часпидани тромботситҳоро боз медоранд.
- Статинҳо (аторвастатин, симвастатин, розувастатин ва ғ.) – сатҳи холестеринро тавассути муҳосираи пайдоиши ӯ ва афзун гардонидани пайвастишавии ЛПЗП (холестерини «бадсифат»)-ро дар чигар паст месозанд.
- β-адреномуҳосирагарҳо (атенолол, бисопролол, небиволол ва ғ.) – таъсири чунин ҳормонҳо, баҳусус адреналинро ҷуброн (ғалофӣ) гардониди, дилзаниро кам, сатҳи фишорро паст ва хунгардишро хуб мегардонанд.
- Нитратҳо (нитросорбид, нитроглицерин, н-глицерин, изосорбиди динитрат ва ғ.) – рағҳои хунгардро васеъ, фишори шараёнро паст ва дардро бартараф мекунад.
- Ингибиторҳои ферменти ангиотензин-табдилдиҳанда (ИФАТ) (эналаприл, рамиприл, лизиноприл ва ғ.), фаъолияти ҳормони ангиотензини-2-ро, ки рағҳоро танг месозад муҳосира намуда, фишори шараёнро муътадил месозанд.
- Муҳосирагарҳои ретсепторҳои ангиотензин-2 (телмисартан, ирбесартан, валсартан, лозартан, кандесартан ва ғ.) – ба мисли ИФАТ таъсир расонида, фишорро паст месозанд – ҳангоми мамнуъ ба ИФАТ ва ё самараҳои номатлуби ИФАТ, ин доруҳо таиноти худро пайдо мекунад.
- Муҳосирагарҳои ҷуйчаҳои калтсий (амлодипин, верапамил, дилтиазем) – мушакҳоро суст, шараёнҳоро васеъ, фишорро паст, таппиши дилро кам (верапамил, дилтиазем) месозанд.
- Диуретикҳо (фуросемид, индапамид, гидрохлортиазид, верошпирон ва ғ.) – барзиёдии намак ва обро аз организм бароварда, фишори шараёнро паст месозанд.

Таботати ҷарроҳӣ

Дар марҳилаҳои дери атеросклероз дар суръати бесамар ва ё ғайрипазирии пасти табобати доругӣ барқарорсозии ҷарроҳии қобилияти гузароии рағҳои коронарӣ нишондод дорад. Вазифаи ин тазриқҳо – беҳ-

созии гузаштани хун ба мушакҳои дил, аз байн бурдани дард ва паст сохтани хавфи оризаҳо, аз он ҷумла, хуручи дил мебошад.

- Дахлатҳои тавассутипусти коронарӣ, ё ки ангиопластикаи коронарӣ – имкони кушодани шараёнҳои муҳосира ва ё танггаштаре медиҳад. Тазриқро бо мақсади ҷӣ пешгирии сакта, ва ҷӣ табобати очилӣ – ҳангоми хуручи дил, мегузаронанд.
- Шунтгузориҳои шохраг-коронарӣ – истифодаи рағҳои солимно аз дигар қисматҳои организм бо мақсади «иваз» ва ё ба таври «убур» гузаштани шараёнҳои коронарии танг ва ё маҳкамгашта дар назар дорад.
- Ивазкунии дили донорӣ – ҷораи охирин дар ҳолатҳои мавҷудияти иллати вазнини мушакҳои дил, ҳангоми фойданопазирӣ усулҳои дигари табобатӣ.

3.3. Пешгирӣ

Пешгирии аввалия – ин роҳ надодан ба пайдоиши БИД мебошад: тарзи ҳаёти солим, муоинаҳои мунтазами тиббӣ, риояи вазни муносиби бадан.

Мақсади *пешгирии дуҷумин* – боздошт ва батахиргузориҳои ҷараёни беморӣ бо мақсади пешгирии оризаҳои эҳтимолӣ, ки тавассути табобати муносибу пурра ва риояи принципҳои тарзи ҳаёти солим ба даст меояд.

Пешгирии сеҷумин – барқарорсозӣ бо мақсади пешгирӣ ва пастсозии сатҳи маъҷубӣ ва фавт.

3.4. Пешгӯӣ

Муайянсозии пешгӯи ҳангоми БИД яке аз масъалаҳои басо мушкил мебошад, ҷунки ба инобат гирифтани омилҳои бисёру бо ҳам алоқамандро, ки аҳамияти гуногуни пешгӯиро доранд, дарбар мегирад.

Асоси пешгӯиро ба инобат гирифтани: 1) маълумотҳои анамнез; 2) падидаҳои клиникии БИД; 3) маълумотҳои тадқиқотҳои дастгоҳӣ; 4) омилҳои хавф ва дараҷаи муқобилият бо онҳо; 5) хусусияти табобат, ташкил медиҳанд.

Аз маълумотҳои анамнез аҳамияти номуносиби пешгӯиро сактаи ба наздикӣ (то 1 сол) гузаронида дорад. Алаҳхусус пешгӯии нохубро бемороне, ки фавти нобаҳангоморо бо эҳёи муваффақ гузаронидаанд, доранд.

Стенокардияи аввалинбор пайдошуда ва болорав (хуручкунанда) пешгӯии номуносибро доранд.

Пешгӯӣ ҳангоми стенокардияи шиддати устувор аз руи синфҳои вазифавияш муайян карда мешавад. Пешгӯӣ дар беморони дорои стенокардияи шиддати I-ум ва II-юм синфи вазифавӣ муносибтар, нисбат ба синфҳои III-IV шуморида мешавад.

Пайдоиши хуруҷҳои стенокардияи стихиявӣ дар беморони дорои стенокардияи шиддат пешгӯиро номуносиб гардонида, ўро бо ин нишондодаш ба пешгӯии стенокардияи ноустувор наздик мегардонад.

Тестҳои санҷишӣ

1. Бо кадом нишондодҳояш БИД дар сохтори бемориҳои дилу раг дар ҷои аввал меистад?
 - А. Бо нишондоди беморшавӣ.
 - Б. Бо нишондоди маъюбшавӣ.
 - В. Бо нишондоди фавт.
 - Г. Бо нишондоди фавт ва маъюбшавӣ.
2. Чаро нишондодҳое, ки аз таҳқиқотҳои скринингии яклухт ба даст меоянд нисбат ба нишондодҳое, ки аз мурочиат ба даст меояд баланд ва дақиқтар мебошанд?
 - А. Чунки таҳқиқотҳои скринингӣ маълумотро аз мурочиати беморон ба даст меоранд.
 - Б. Маълумотҳои аз скрининг ба даст омада нишондодҳои беморони диспансериро дар бар мегиранд.
 - В. Маълумотҳои аз скрининг ба даст омада нишондодҳои беморшавии аввалия, беморшавии умумӣ ва бемориҳои замшударо дарбар мегиранд.
 - Г. Чунки таҳқиқотҳои скринингӣ маълумотро аз муоинаи коллективҳои муташакил ба даст меоранд.
3. Кадоме аз ин се омилҳо исботи баланди илмиро (сатҳи исботи А) оиди саҳмашон дар пайдоиш ва болоравии БИД мебозанд?
 - А. Тамокукашӣ, фарбеҳӣ, истифодаи барзиёди нушокиҳои спиртдор.
 - Б. Камҳаракатӣ, истифодаи барзиёди намаки ошӣ, диабет.
 - В. Афзунии холестерин, фарбеҳӣ, омилҳои рӯҳӣ-эҳсосӣ.
 - Г. Фишорбаландии шараёнӣ, афзунии холестерин, тамокукашӣ.
4. Ба омилҳои тағирнопазири БИД мансубанд ҳама номбаршудагон, ба истисноӣ:
 - А. Синну сол.
 - Б. Стресс.
 - В. Ҷинс.
 - Г. Ирсият.
5. Сатҳи алақай аз меъёр баланди липидҳо шуморида мешавад:

- А. ХсУ >6 ммол/л, Хс ЛПЗП >3,5 ммол/л; Хс ЛПЗБ <1,2 ммол/л барои мардҳо ва <1,3 ммол/л барои занҳо; ТГ >2,0 ммол/л.
- Б. ХсУ >5,6 ммол/л, Хс ЛПЗП >3,2 ммол/л; Хс ЛПЗБ <1,2 ммол/л барои мардҳо ва <1,0 ммол/л барои занҳо.
- В. ХсУ >5,0 ммол/л, Хс ЛПЗП >3,0 ммол/л; Хс ЛПЗБ <1,0 ммол/л барои мардҳо ва <1,2 ммол/л барои занҳо; ТГ >1,8 ммол/л.
- Г. ХсУ >4,8 ммол/л, Хс ЛПЗП >3,5 ммол/л; Хс ЛПЗБ <0,9 ммол/л барои мардҳо ва <1,0 ммол/л барои занҳо; ТГ >1,2 ммол/л.
6. Бармаҳал шуморида мешавад агар падидаҳои БИД пайдо шаванд?
- А. Дар падар ва ё бародарҳо то синни 55 ва дар модар ва хоҳару апаҳо то синни 65 солагӣ.
- Б. Дар падар ва ё бародарҳо то синни 50 ва дар модар ва хоҳару апаҳо то синни 60 солагӣ.
- В. Дар падар ва ё бародарҳо то синни 65 ва дар модар ва хоҳару апаҳо то синни 70 солагӣ.
- Г. Дар падар ва ё бародарҳо то синни 45 ва дар модар ва хоҳару апаҳо то синни 55 солагӣ.
7. Сабабҳои асосии БИД ҳама номбаршудагон, ба истисноӣ:
- А. Тангшавии (спазм) рагҳои коронарӣ.
- Б. Афзунии вазни бадан.
- В. Атеросклерози шараёнҳои коронарӣ.
- Г. Суддабандӣ.
8. Стандарти «тиллоӣ» дар ташҳиси БИД ба ҳисоб меравад:
- А. Велоэргометрия.
- Б. Ташҳиси липидҳои хун.
- В. Эхокардиография.
- Г. Коронарография.
9. Шакли бедарди БИД-ро бештар ҳангоми кадом беморӣ мушоҳида мекунанд?
- А. Бемории Алцгеймер.
- Б. Бемории Рейно.
- В. Диабети қанд.
- Г. Бемории Адисон-Бирмер.

10. Кадом вақт БИД намуди бо монета (обструктивӣ) шуморида мешавад?
- А. Агар рағҳои коронарӣ $>70\%$ танг ва ё муҳосира гашта бошанд.
 - Б. Агар рағҳои коронарӣ $>60\%$ танг гашта бошанд.
 - В. Агар рағҳои коронарӣ $>90\%$ танг гашта бошанд.
 - Г. Агар рағҳои коронарӣ $>50\%$ танг ва ё муҳосира гашта бошанд.
11. Қатъи ҳайз басомад ва вазнинии БИД-ро:
- А. То 3 маротиба баланд мебардорад.
 - Б. То 5 маротиба баланд мебардорад.
 - В. То 7 маротиба баланд мебардорад.
 - Г. То 9 маротиба баланд мебардорад.
12. Шакли аз ҳама беш вохӯрандаи БИД – ин:
- А. Вайроншавии назм ва муҳосираҳо.
 - Б. Стенокардияи устувор.
 - В. Шакли бедарди ишемияи миокард.
 - Г. Стенокардияи микроваскулярӣ.
13. Ғизои солим дарбар мегирад:
- А. Истеъмоли $<5\text{г}$ намаки оширо дар давоми рӯз.
 - Б. Маҳдудгардонии истеъмоли чарбҳои сершударо ($<10\%$ аз нерӯи умумии ғизо) бо роҳи ивази онҳо ба туршакҳои чарбҳои нимсер, ҳангоми имконият тадриҷан маҳдудсозии трансчарбҳо ($<1\%$ аз нерӯи асосии ғизо).
 - В. Истеъмоли қариб 500г меваю сабзавотро дар як рӯз, 30-45г нахҳои ғизоиро, истифодаи мохиро на кам аз 2 маротиба дар 1 ҳафта (1-тояш серравған), маҳдудсозии истеъмоли нӯшокиҳои спиртдорро то 20г барои мардҳо ва то 10г барои занҳо.
 - Г. Ҳама номбаршудагонро.
14. Стандарти «тиллоӣ»-и табobati бемории БИД ба ҳисоб меравад:
- А. Қабули нитратҳо.
 - Б. Истифодаи антиагрегантҳо.
 - В. Истифодаи β -муҳосирагарҳо.
 - Г. Қабули статинҳо.
15. Тавассути кадом усули таҳқиқ метавон алоими Х (стенокардияи микроваскулярӣ)-ро хубтар аниқ намуд?

А. Эхокардиографияи стрессӣ.

Б. Томографияи магнитуи резонансии дил.

В. Томографияи позитронию эмиссионии дил.

Г. Ангиографияи коронарӣ.

16. Мақсад аз кабули β -адренормуҳосирагарҳо ҳангоми стенокардия?

А. Таъмини самараи зидди ангиналӣ – бо муҳосираи таъсири ҳормонҳои симпатикӣ кам кардани таппиши дил, фишори шараён ва мутаносибан беҳсозии хуншорӣ тавассути рағҳои коронарӣ ба мушакҳои дил, ки ҳангоми диастолаи бардавом таъмин мегардад.

Б. Таъмини самараи зидди агрегантӣ – бо кам гаштани таъсири симпатикӣ мутаносибан хуб гаштани шумораи таппиши дил, фишори шараёнӣ ва, дар ниҳоят, паст гаштани сатҳи лахташавии хун.

В. Таъмини самараи зидди фишорбаландӣ – бо кам гаштани сатҳи ҳормонҳои симпатикӣ мутаносибан паст гаштани сатҳи фишори шараён, ки омили аз ҳама ҷиддии БИД ба ҳисоб меравад.

Г. Таъмини самараи зидди дилзанӣ тавассути кам кардани таъсири ҳормонҳои адренерҷӣ дар бемороне, ки дилзаниро доранд.

17. Барои ташхисгузории БИД чунин тактикаро бояд риоя намуд:

А. Ҳарчи зудтар ҳангоми шубҳа гузаронидани ангиокардиография, сипас муқоисакунонии натиҷаҳои он бо нишонаҳои клиникии беморӣ барои аз даст надодани вақт.

Б. Истифодаи усулҳои сарбориҳои стрессӣ, бинобар ғайриинвазивӣ буданашон, сипас гузаронидани ангиографияи коронарӣ бо мақсади пуррасозии ташхис.

В. Истифодаи усули аз ҳама оддӣ ва дастрас – сабти барқии дил, ки дар 90% ҳолатҳо аз 100% ташхисро муайян месозад.

Г. Ҷамъовариҳои нишонаҳои субъективию объективии беморӣ, баҳодихии омилҳои ҳавф, сипас таини усулҳои ташхисӣ сар карда аз усулҳои аз ҳама дастрас ва ғайриинвазивӣ, бо ба анҷом расонӣ (ҳангоми зарурат ва нишондод) ба усулҳои инвазивию маблағталаб – ҳангоми ҷой доштани нишондод.

18. Сабаби асосии таиноти беасоси усулҳои ташхисӣ, аз он ҷумла инвазивӣ (мисол, коронарография) ҳангоми БИД – ин:
- А. Сатҳи пасти дониши табиб оиди усулҳои ташхисӣ.
 - Б. Надоштан ва ё паст будани тасавурот оиди нишонаҳои клиникии беморӣ.
 - В. Надоштани дониш оиди нишондодҳо ба таиноти ин ва ё он усули ташхисӣ.
 - Г. Сатҳи пасти донишу малака оиди тартиби ташхисоти беморӣ ва бевиҷдонии табиб.
19. Пешгирии аввалияи БИД дарбар мегирад:
- А. Қабули доимии статинҳоро.
 - Б. Таинот ва қабули доимии доруҳои зидди агрегантиро.
 - В. Риояи принципҳои тарзи ҳаёти солим, аз байн бурдани омилҳои хавфро.
 - Г. Қабули β -муҳосирагарҳо ва статинҳоро.
20. Пешгирии дуюмини БИД дарбар мегирад:
- А. Табобати ғайридоругӣ, ҷарроҳӣ ва доругӣ, аз он ҷумла статинҳоро.
 - Б. Ташаккули тарзи ҳаёти солимро.
 - В. Қабули доимии нитратҳоро.
 - Г. Табобати ҷарроҳиро.

Калиди чавоб ба тестҳо

1	Г	2	В	3	Г	4	Б	5	В
6	А	7	Б	8	Г	9	В	10	Г
11	А	12	Б	13	Г	14	Г	15	В
16	А	17	Г	18	Г	19	В	20	А

Адабиёт

1. Вайсман Д.Ш. Руководство по использованию Международной классификации болезней в практике врача: в 2-х томах. 2-е изд. Москва, ФБГУ «ЦНИИОИЗ», 2022. Том 1-2. 514с.
2. Кардиология. Национальное руководство. Краткое издание / под ред. Е.В. Шляхто. – 2-е изд., перев. и дополь. – Москва.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. С. 408-423.
3. Козлов К.Л., Шанин В.Ю. Ишемическая болезнь сердца. Клиническая фармакотерапия, хирургическое лечение. СПб, Наука, 2002. С. 5-332.
4. Котова Е.Г., Кобякова О.С., Стародубова В.И. и др. Заболеваемость всего населения России в 2022 году: статистические материалы. М.: ФБГУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России, 2023.
5. Любимов А.В., Черкашин Д.В., Аланичев А.Е. Перспективы кардиопротекции с помощью ишемического preconditionирования: гипоксия-индуцируемый фактор 1-возможный молекулярный механизм и мишень, для фармакотерапии // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. - 2017. - Т.16, - №6. - С. 139-147.
6. Нозиров Ч.Х., Рахимов З.Я., Нарзуллаева А.Р. Школа здоровья. Дастури таълимӣ-услугӣ. Душанбе, 2016. С. 78.
7. Нозиров Ч.Х. Ишемическая болезнь сердца и факторы её риска в Таджикистане. Монография. Душанбе, 2020. С. 8-40.
8. Нозиров Ч.Х. Медико-социальные аспекты сердечно-сосудистых заболеваний (ишемическая болезнь сердца и артериальной гипертензия) и пути совершенствование кардиологической помощи на популяционном уровне в Республике Таджикистан. рис. док. илм-хои. тиб. Душанбе, 2018. С. 76-77.
9. Оганов Р.Г., Беленков Ю.Н., Мамедов М.Н. Кардиология: практические аспекты (второе издание). Москва, 2019. С. 86-95.
10. Раҳимов Ч.Қ. Прекондитикунонии ишемиявии миокард дар бемории стенокардияи устувор дар заминаи фишорбандии шараёнии резистентӣ. Авҷи зухал, 2022. - №1(46). - С. 37-42.

11. Солимии аҳолӣ ва фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ дар соли 2023. Муассисаи давлатии «Маркази ҷумҳуриявии омор ва иттилооти тиббӣ». Душанбе, 2024. С. 72.
12. International statistical classification of diseases and related health problems. 10 th revision, Fifth addition, WHO. Geneva. 2016. V. 2.
13. Fadi J Charchar, Lisa Ds Bloomer, Timothy A Barnes. Inheritance of coronary artery disease in men: an analysis of the role of the Y chromosome // Lancet. - 2012. - Вып. 379(9819). - С. 915-922.
14. Juhani Knuuti, William Wijns, Antti Saraste. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes: The Task Force for the diagnosis and management of chronic coronary syndromes of the European Society of Cardiology (ESC) // European Heart Journal. - 2020. - Вып. 41. - С. 407-477.
15. National Kidney Foundation. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification // Am J Kidney Dis. - 2002. - Вып. 39.
16. Salim Yusuf, Steven Hawken, Stephanie Ounpuu. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control stud // Lancet. - 2004. - Вып. 364(9438).

Ба ҷопаш 15.05.2025с. ба ҷамъо расид.

Андоза 60x84 1/16.

Адади нашр 100 нусха.

Дар матбааи "Истиқлол-2019" ҷоп шудааст.

734036, ш. Душанбе, к. Н. Қарабоев 60.

Тел.: (+992 37) 234-78-78. E-mail: istiklol_2019@bk.ru



002268075

Китобхонаи миллии Тоҷикистон